LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah: Rekayasa Arsitektur Basis Data
Praktikum Pertemuan 1 – Identifikasi Stakeholder dan Konteks Organisasi

STAKEHOLDER ANALYSIS DAN POWER–INTEREST GRID

Implementasi Sistem Informasi Klinik Terintegrasi – Klinik Sehat Bersama

Nama :
Alfisar 2507043
Ine Marhamah Putri 2507067

INSITUT TEKNOLOGI GARUT
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 2026

1. Profil Kasus

Klinik Sehat Bersama adalah klinik kesehatan swasta yang melayani pemeriksaan umum, konsultasi dokter, tindakan medis, dan pelayanan obat. Sebagian proses pelayanan masih dilakukan dengan pencatatan manual dan beberapa aplikasi yang tidak saling terintegrasi. Akibatnya pelayanan kurang efisien, pencarian riwayat pasien memakan waktu, dan laporan operasional disusun secara terpisah.

Manajemen berencana mengembangkan Sistem Informasi Klinik Terintegrasi. Proyek dipimpin oleh Kepala Klinik dan dikerjakan bersama vendor pengembang.

1.1 Proses Kerja Utama

- Pendaftaran pasien dan pengelolaan data pasien
- Pemeriksaan dokter dan pengelolaan rekam medis
- Pencatatan tindakan medis oleh perawat
- Resep dan pengelolaan obat (stok)
- Pembayaran oleh kasir
- Penyusunan laporan manajemen

1.2 Kendala Proyek

- **Anggaran terbatas:** tidak semua fitur dapat dikembangkan sekaligus sehingga perlu prioritas.
- **Waktu:** sistem harus dapat digunakan pada jadwal yang ditetapkan manajemen.
- **Keamanan data:** data pasien bersifat sensitif sehingga pengaturan akses dan keamanan menjadi perhatian utama.
- **Adaptasi pengguna:** peralihan dari proses manual ke sistem terkomputerisasi memerlukan waktu adaptasi dan pelatihan bagi tenaga klinik.

2. Metode Analisis

Analisis memakai Power–Interest Grid, yaitu pemetaan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh (power) dan tingkat kepentingan (interest) sebagaimana dijelaskan pada materi praktikum (Boutilier, 2024). Setiap stakeholder dinilai pada skala 1–5.

Skala	Power (Pengaruh)	Interest (Kepentingan)
1	Sangat rendah: hampir tidak punya pengaruh	Sangat rendah: hampir tidak peduli, dampak kecil
2	Rendah: punya suara, tetapi tidak signifikan dalam keputusan	Rendah: kadang terpengaruh, tidak signifikan
3	Sedang: dapat memengaruhi jalannya proyek, bukan faktor penentu	Sedang: ada kepentingan, tetapi tidak mendesak
4	Tinggi: berpengaruh kuat terhadap kebijakan dan jalannya proyek	Tinggi: kepentingan besar, hasil proyek langsung memengaruhi mereka
5	Sangat tinggi: penentu utama keberhasilan atau kegagalan proyek	Sangat tinggi: sangat peduli dan bergantung pada hasil proyek

Nilai 4–5 dikategorikan High dan nilai 1–3 dikategorikan Low. Ambang ini mengikuti contoh kasus e-learning pada modul, yang menempatkan Dosen (Power 3, Interest 4) pada Low Power–High Interest dan Vendor (Power 4, Interest 3) pada High Power–Low Interest. Dengan ambang tersebut terbentuk empat kuadran:

- **Kelola secara dekat** (High Power – High Interest)
- **Jaga kepuasan** (High Power – Low Interest)
- **Libatkan dan komunikasi rutin** (Low Power – High Interest)
- **Cukup dimonitor** (Low Power – Low Interest)

3. Identifikasi Stakeholder

Teridentifikasi 12 stakeholder: 10 disebut langsung dalam studi kasus dan 2 ditambahkan berdasarkan konteks kasus (ditandai dengan tanda bintang).

No	Stakeholder	Peran dalam Proyek	Kebutuhan / Kepentingan
1	**Pemilik Klinik**	Sponsor/penyandang dana; pemilik bisnis klinik	Sistem meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pengembangan bisnis
2	**Kepala Klinik**	Pemimpin proyek; penghubung manajemen dan tim proyek	Sistem yang mengintegrasikan proses pelayanan dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan
3	**Divisi IT**	Implementasi, keamanan, integrasi, dan pemeliharaan sistem	Sistem aman, dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ada, dan mudah dipelihara
4	**Dokter**	Pengguna utama: konsultasi, pemeriksaan, rekam medis, resep	Akses cepat ke riwayat kesehatan pasien dan hasil pemeriksaan
5	**Perawat**	Pengguna: pencatatan tindakan dan kondisi pasien	Sistem yang mudah digunakan untuk mencatat tindakan dan kondisi pasien
6	**Petugas Pendaftaran**	Pengguna: pendaftaran pasien dan pengelolaan data pasien	Proses pendaftaran lebih cepat sehingga antrean berkurang
7	**Apoteker**	Pengelola resep dan stok obat	Informasi resep yang akurat dan stok obat yang selalu diperbarui
8	**Petugas Kasir/Keuangan**	Pengguna: pembayaran dan laporan transaksi	Pencatatan pembayaran dan laporan transaksi yang akurat
9	**Vendor Pengembang**	Pihak eksternal yang membangun dan menyesuaikan sistem	Kebutuhan dan ruang lingkup yang jelas, jadwal realistis, dan pembayaran kontrak
10	**Pasien**	Pengguna layanan (eksternal)	Pendaftaran dan pelayanan lebih cepat, informasi akurat, data pribadi terjaga

No	Stakeholder	Peran dalam Proyek	Kebutuhan / Kepentingan
11	**Regulator (Otoritas Kesehatan & Pelindungan Data) ***	Pihak eksternal pengawas kepatuhan rekam medis dan data pribadi	Sistem memenuhi kewajiban pencatatan rekam medis dan pelindungan data pribadi pasien
12	**Supplier Obat ***	Pemasok obat (eksternal)	Pemesanan yang teratur dan pembayaran tepat waktu

** Regulator ditambahkan karena kasus menekankan keamanan dan akses data pasien. Supplier Obat ditambahkan karena sistem mencakup pengelolaan stok obat. Keduanya adalah asumsi penulis dan bukan bagian dari teks kasus.*

4. Penilaian Power dan Interest

Tabel berikut memuat nilai Power dan Interest beserta argumentasinya.

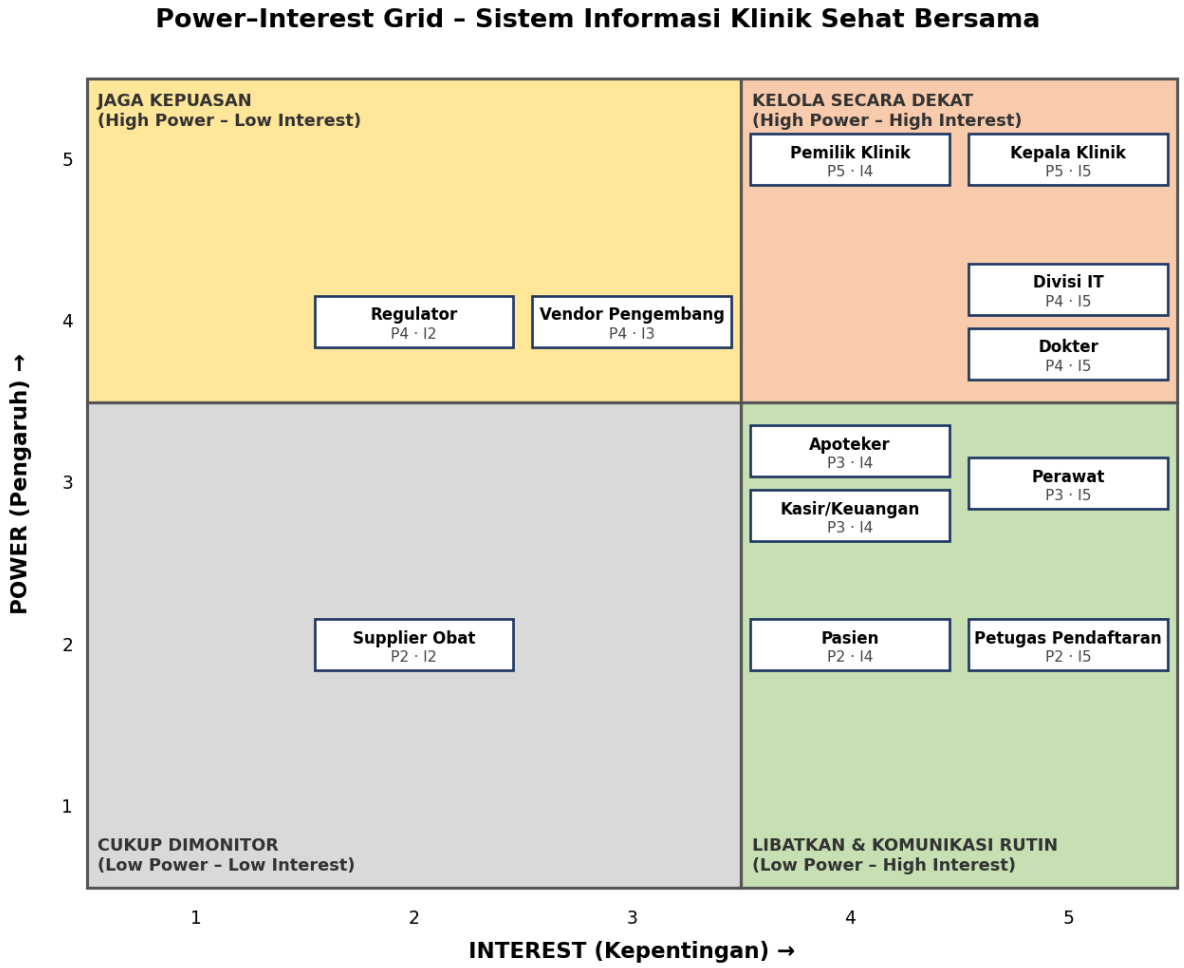
No	Stakeholder	Power	Interest	Alasan Nilai Power	Alasan Nilai Interest
1	**Pemilik Klinik**	5	4	Memegang keputusan akhir atas investasi, anggaran, dan kelanjutan proyek. Karena anggaran terbatas, Pemilik yang menentukan fitur mana yang didanai lebih dulu.	Hasil proyek berdampak langsung pada reputasi dan pertumbuhan bisnis. Tidak diberi 5 karena tidak terlibat dalam operasional harian.
2	**Kepala Klinik**	5	5	Memimpin proyek: menetapkan ruang lingkup, jadwal, dan koordinasi seluruh pihak; keputusan operasional proyek ada di tangannya.	Keberhasilan proyek menjadi tanggung jawab langsung, dan laporan manajemen dari sistem menjadi dasar keputusannya.
3	**Divisi IT**	4	5	Mengendalikan aspek teknis (integrasi, keamanan, hak akses, pemeliharaan). Tidak diberi 5 karena bukan pengambil keputusan anggaran dan strategi.	Menanggung operasional sistem jangka panjang; masalah keamanan atau integrasi menjadi beban langsung divisi ini.
4	**Dokter**	4	5	Otoritas klinis dan pengisi rekam medis. Jika dokter menolak atau tidak disiplin menggunakan sistem, data rekam medis tidak lengkap dan adopsi gagal. Tidak 5 karena tidak mengatur anggaran dan kebijakan proyek.	Rekam medis dan pemeriksaan adalah inti pekerjaan harian; kualitas sistem langsung memengaruhi kecepatan dan ketepatan layanan.
5	**Perawat**	3	5	Berpengaruh pada kelengkapan data klinis dan adopsi di lapangan, tetapi tidak menentukan keputusan proyek.	Mencatat data setiap hari; cara kerja berubah dari manual ke digital sehingga butuh adaptasi dan pelatihan.
6	**Petugas Pendaftaran**	2	5	Pengaruhnya terbatas pada modul pendaftaran; memberi masukan alur, tetapi bukan pengambil keputusan.	Garda terdepan layanan; proses yang paling terasa berubah dari pencatatan manual, dan efisiensi langsung terlihat pada antrean.

No	Stakeholder	Power	Interest	Alasan Nilai Power	Alasan Nilai Interest
7	**Apoteker**	3	4	Menentukan kebutuhan modul farmasi dan validasi resep; bergantung pada integrasi dengan dokter, tetapi tidak menentukan arah proyek.	Kesalahan resep atau stok berdampak langsung pada keselamatan pasien dan operasional farmasi; dampak terpusat di modul farmasi, sehingga 4.
8	**Petugas Kasir/Keuangan**	3	4	Menentukan kebutuhan modul pembayaran dan laporan keuangan, tetapi tidak memegang kendali anggaran proyek.	Akurasi transaksi dan laporan adalah tugas utamanya; hasil proyek langsung memengaruhi pekerjaannya.
9	**Vendor Pengembang**	4	3	Memegang kendali teknis pengembangan, kualitas, dan jadwal; klinik bergantung pada vendor untuk hasil akhir.	Berkepentingan pada penyelesaian kontrak dan reputasi, tetapi tidak terdampak langsung oleh operasional klinik; diasumsikan juga menangani proyek lain.
10	**Pasien**	2	4	Tidak ikut memutuskan proyek; pengaruhnya tidak langsung melalui kepuasan, keluhan, atau pindah ke klinik lain.	Pengalaman layanan dan pengelolaan data kesehatannya dipengaruhi langsung oleh sistem, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan proyek.
11	**Regulator (Otoritas Kesehatan & Pelindungan Data)**	4	2	Dapat memberi sanksi atau memengaruhi izin operasional bila sistem melanggar ketentuan rekam medis dan pelindungan data.	Tidak peduli pada proyek ini secara khusus; baru berkepentingan saat ada audit, inspeksi, atau pelanggaran.
12	**Supplier Obat**	2	2	Memengaruhi ketersediaan obat, tetapi tidak memengaruhi keputusan atau jalannya proyek sistem.	Dampak tidak langsung; hanya akan merasakan perubahan jika pemesanan terhubung dengan data stok.


Stakeholder Map
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Petugas Pendaftaran
Dokter
Perawat
Divisi IT
Kepala Klinik
Petugas
Kasir/Keuangan
Pasien
Pemilik Klinik
Apoteker
Vendor Pengembang
Supplier Obat
Regulator (Otoritas Kesehatan &
Pelindungan Data)

5. Power–Interest Grid

Gambar berikut menempatkan seluruh stakeholder pada grid. Sumbu vertikal menunjukkan Power dan sumbu horizontal menunjukkan Interest. Kode P dan I pada tiap kotak adalah nilai Power dan Interest.



Gambar 1. Power–Interest Grid Sistem Informasi Klinik

No	Stakeholder	Power	Interest	Posisi pada Grid
1	**Pemilik Klinik**	5	4	Kelola Secara Dekat
2	**Kepala Klinik**	5	5	Kelola Secara Dekat
3	**Divisi IT**	4	5	Kelola Secara Dekat
4	**Dokter**	4	5	Kelola Secara Dekat
5	**Perawat**	3	5	Libatkan & Komunikasi Rutin
6	**Petugas Pendaftaran**	2	5	Libatkan & Komunikasi Rutin
7	**Apoteker**	3	4	Libatkan & Komunikasi Rutin
8	**Petugas Kasir/Keuangan**	3	4	Libatkan & Komunikasi Rutin
9	**Vendor Pengembang**	4	3	Jaga Kepuasan
10	**Pasien**	2	4	Libatkan & Komunikasi Rutin

No	Stakeholder	Power	Interest	Posisi pada Grid
11	**Regulator (Otoritas Kesehatan & Pelindungan Data)**	4	2	Jaga Kepuasan
12	**Supplier Obat**	2	2	Cukup Dimonitor

6. Strategi Pengelolaan per Kuadran

Kuadran	Strategi	Bentuk dan Frekuensi Komunikasi
Kelola Secara Dekat (Power ≥ 4 dan Interest ≥ 4)	Libatkan secara intensif dalam pengambilan keputusan, desain, dan pengujian; komunikasi dua arah dan sering.	Rapat mingguan/dua mingguan, steering committee, workshop kebutuhan, review progres dan risiko
Jaga Kepuasan (Power ≥ 4 dan Interest ≤ 3)	Pastikan harapan mereka terpenuhi tanpa membebani dengan informasi detail; hindari kejutan.	Laporan milestone ringkas, SLA/kontrak, checklist kepatuhan, pertemuan berkala saat milestone
Libatkan & Komunikasi Rutin (Power ≤ 3 dan Interest ≥ 4)	Beri informasi rutin, pelatihan, dan ruang masukan; mereka pendukung adopsi dan sumber kebutuhan pengguna.	Pelatihan, UAT/pilot, kanal feedback, pengumuman perubahan, super user
Cukup Dimonitor (Power ≤ 3 dan Interest ≤ 3)	Pantau dengan usaha minimal; naikkan prioritas bila posisinya berubah.	Pemberitahuan seperlunya, tinjau posisi pada setiap fase proyek

7. Penjelasan Kelompok Stakeholder

7.1 Stakeholder yang Perlu Dikelola secara Dekat

Kelompok ini memiliki pengaruh besar sekaligus kepentingan tinggi, sehingga keputusan dan dukungan mereka menentukan keberhasilan proyek. Mereka perlu dilibatkan sejak perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pengujian.

- **Pemilik Klinik (P5, I4):** Laporan ringkas berkala (progres, biaya, risiko); minta keputusan prioritas fitur (pendekatan bertahap/MVP) sesuai anggaran.
- **Kepala Klinik (P5, I5):** Jadikan sebagai ketua steering committee; rapat progres mingguan; sepakati project charter dan jadwal sejak awal.
- **Divisi IT (P4, I5):** Koordinasi intensif dengan vendor; libatkan sejak desain arsitektur, kebijakan hak akses (role-based), dan backup data.
- **Dokter (P4, I5):** Libatkan perwakilan dokter dalam workshop kebutuhan rekam medis dan resep; uji coba (pilot); tampung masukan secara cepat.

7.2 Stakeholder yang Perlu Dijaga Kepuasannya

Kelompok ini berpengaruh besar tetapi tidak terlibat dalam proyek sehari-hari. Ketidakpuasan mereka dapat menghambat proyek, sehingga harapan mereka perlu dipenuhi tanpa membebani dengan informasi yang terlalu rinci.

- **Vendor Pengembang (P4, I3):** Kontrak dan SLA yang jelas, pelaporan milestone, kontrol perubahan kebutuhan (change request), jaga hubungan baik.
- **Regulator (Otoritas Kesehatan & Pelindungan Data) (P4, I2):** Susun checklist kepatuhan sejak desain (audit log, hak akses, retensi data); verifikasi ketentuan terbaru sebelum implementasi.

7.3 Stakeholder yang Perlu Dilibatkan melalui Komunikasi Rutin

Kelompok ini adalah pengguna langsung sistem. Pengaruh mereka terhadap keputusan proyek terbatas, tetapi sistem yang tidak sesuai kebutuhan mereka akan sulit diadopsi. Mereka perlu mendapat informasi rutin, pelatihan, dan ruang untuk memberi masukan.

- **Perawat (P3, I5):** Pelatihan bertahap, antarmuka sederhana, tunjuk 'super user' dari perawat, sediakan panduan singkat.
- **Petugas Pendaftaran (P2, I5):** Uji coba alur pendaftaran (UAT), pelatihan, kanal masukan cepat selama masa awal penggunaan.
- **Apoteker (P3, I4):** Validasi alur resep-ke-stok bersama apoteker; UAT modul farmasi; informasikan jadwal rilis fitur stok.
- **Petugas Kasir/Keuangan (P3, I4):** UAT modul pembayaran, uji rekonsiliasi laporan transaksi, pelatihan, dan kanal pelaporan masalah.
- **Pasien (P2, I4):** Survei kepuasan, pengumuman perubahan layanan, kanal keluhan, dan informasi singkat tentang perlindungan data.

7.4 Stakeholder yang Cukup Dimonitor

Kelompok ini memiliki pengaruh dan kepentingan rendah terhadap proyek. Cukup dipantau dengan usaha minimal, dan posisinya ditinjau ulang bila kondisi proyek berubah.

- **Supplier Obat (P2, I2):** Pantau saja; informasikan bila ada perubahan format pemesanan akibat sistem stok baru.

8. Kesimpulan

Dari 12 stakeholder, empat berada pada kuadran Kelola Secara Dekat (Pemilik Klinik, Kepala Klinik, Divisi IT, Dokter), dua pada Jaga Kepuasan (Vendor Pengembang, Regulator), lima pada Libatkan dan Komunikasi Rutin (Perawat, Petugas Pendaftaran, Apoteker, Kasir/Keuangan, Pasien), dan satu pada Cukup Dimonitor (Supplier Obat).

Kendala proyek tercermin pada pemetaan ini. Anggaran terbatas membuat Pemilik dan Kepala Klinik perlu terlibat dalam penentuan prioritas fitur. Keamanan data pasien membuat Divisi IT, Dokter, dan Regulator perlu diperhatikan sejak desain. Kebutuhan adaptasi dan pelatihan membuat para pengguna pada kuadran Libatkan dan Komunikasi Rutin perlu mendapat pelatihan serta kanal masukan yang jelas.

Hasil ini menjadi dasar untuk menentukan narasumber elisitasi kebutuhan pada tahap berikutnya. Nilai Power dan Interest merupakan penilaian subjektif berdasarkan argumentasi pada Bagian 4 dan dapat disesuaikan bila ada informasi baru dari organisasi.

Referensi

Boutilier, R. (2024), sebagaimana dirujuk pada materi Praktikum Pertemuan 1 (Identifikasi Stakeholder dan Konteks Organisasi), mata kuliah Rekayasa Arsitektur Basis Data.